

ESPIRITUALIDADE, RELIGIOSIDADE E RELIGIÃO: UMA DISTINÇÃO QUE IMPORTA NA CLÍNICA

Vivianne Nascimento

O excerto de Oliveira e Junges (2012) faz duas afirmações que merecem ser separadas. A primeira é que a espiritualidade se manifesta como religiosa quando a transcendência transforma de tal modo a vida da pessoa que o experimentado não se explica apenas por forças contidas na sua interioridade, mas é sentido como a presença de um absoluto identificado como Deus, forma a que Vasconcelos (2006) chama mística. A segunda é que espiritualidade e religiosidade se caracterizam pela dimensão essencialmente experiencial, enquanto a religião está calcada no aspeto institucional e doutrinário. Concorro com ambas, e explico porquê.

1 O eixo experiencial e o eixo institucional

A distinção proposta pelos autores coincide com a que o material da disciplina estabelece: a religião é instrucional e doutrinária, regulada por ritos e crenças, ao passo que a espiritualidade é experiencial, o contacto com algo que transcende as realidades normais da vida, uma força interior que supera as próprias capacidades. O que o texto acrescenta, e que considero preciso, é o critério que distingue a espiritualidade genérica da espiritualidade religiosa: não é a filiação a uma instituição, é o facto de a experiência ser sentida como presença de um absoluto.

Esta precisão tem uma consequência decisiva. Se a espiritualidade é experiencial, não depende de pertença religiosa, e qualquer pessoa pode tê-la, incluindo ateus e agnósticos, entendida como a forma que cada um dá sentido à sua vida. O psicólogo que só pergunta pela religião colhe o dado institucional e perde o experiencial, que é o clinicamente relevante.

2 Onde a distinção se torna delicada

Acrescento, contudo, uma ressalva. A separação entre o experiencial e o institucional é analiticamente clara, mas na vida concreta das pessoas os dois eixos misturam-se. A experiência de transcendência chega quase sempre com a linguagem, os símbolos e os ritos de alguma tradição. Uma pessoa que reza raramente distingue o que nela é vivência e o que é doutrina aprendida. Por isso entendo a distinção dos autores como instrumento de análise, não como fronteira rígida: serve para o clínico saber o que está a perguntar, não para arrumar os pacientes em categorias.

3 A relevância para a prática

A pertinência está ancorada institucionalmente: a Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar físico, mental e social, e em 1988 incluiu nesse conceito a dimensão espiritual. O estudo de Oliveira e Junges investiga a visão dos psicólogos sobre o tema, e a dificuldade que muitos ainda sentem em abordá-lo é herdeira de um receio antigo: confundir acolher a espiritualidade do paciente com aderir à sua religião.

É aí que a distinção do texto se torna libertadora. Acolher a dimensão experiencial não exige do psicólogo nenhuma adesão doutrinária, exige apenas que reconheça como o paciente constrói sentido. Concluo, portanto, que o excerto não separa espiritualidade e religião para desvalorizar a segunda, mas para devolver à primeira um estatuto próprio, que a torna finalmente acessível à escuta clínica.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, Márcia Regina de; JUNGES, José Roque. Saúde mental e espiritualidade/religiosidade: a visão de psicólogos. **Estudos de Psicologia**, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2012.

VASCONCELOS, Eduardo Mourão. 2006. Apud OLIVEIRA; JUNGES, 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Conceito ampliado de saúde e inclusão da dimensão espiritual, 1988.

Material da disciplina Psicologia, Espiritualidade, Religiosidade e Niilismo, Unidades I e II.